

AIRWAY KIDS

ATEMWEGS ORIENTIERTE KINDERZAHNHEILKUNDE

“MODERNE KIEFERORTHOPÄDIE THERAPIERT NICHT NUR SCHIEFE ZÄHNE, SONDERN AUCH DIE URSACHEN!”

Zahnärztin Carola Engelberts

Mit Herz, Erfahrung und modernster Technik für die Gesundheit Ihres Kindes.

Bei uns stehen die Bedürfnisse unserer kleinen Patienten im Mittelpunkt. Unser **speziell geschultes Team** begleitet Kinder und Eltern einfühlsam durch jede Behandlungsphase. Eine **kindgerechte Atmosphäre**, moderne **Motivationstools** und **sanfte Behandlungsmethoden** schaffen Vertrauen und sorgen für positive Behandlungserlebnisse.

Durch den **Einsatz innovativer Technologien** – wie **digitale Scans** anstelle klassischer Abdrücke, **strahlungsarme, sehr genaue digitale Röntgendiagnostik** und **moderne kieferorthopädische Schienensysteme** – können wir Behandlungen besonders komfortabel, präzise und schonend durchführen.

Dabei legen wir besonderen Wert auf eine **atemwegsorientierte Behandlung**, um die natürliche Entwicklung von Kiefer, Gesicht und Atmung **zum richtigen Wachstumszeitpunkt optimal zu unterstützen.**

STECKBRIEF

Carola Engelberts



Zahnärztin und Inhaberin der Praxis Richmodent

– seit 26 Jahren in Köln –

„Immer wieder werde ich gefragt, wie ich auf dieses recht neue Thema der atemwegsfokussierten Zahnmedizin gekommen bin – und die Antwort ist:

Durch unser eigenes Kind – unsere älteste Tochter!

Das stetige innere Gefühl, dass etwas nicht stimmt: das Schnarchen, das nicht normal sein kann, dazu die schief durchbrechenden Zähne.

Mit der Erkenntnis, sie mit den herkömmlichen Methoden nicht wirklich therapieren zu können, und dem inneren Drang, nach Lösungen zu suchen, begann ich, das an der Universität Gelernte kritisch zu hinterfragen und im
Ausland nach Alternativen zu suchen – und diese habe ich in vielen Fortbildungen gefunden.

Aus vielen Einzelteilen habe ich das **Airway-Kids-Konzept** entwickelt, da nicht jede gelernte Therapie zu jedem Kind passt und oft die Eltern ebenfalls therapiert werden möchten, da sie die Symptome auch bei sich erkennen!

Seit 2005 therapiere ich mit Teilen unseres Konzeptes und habe mittlerweile **mehr als 4.000 Kinder** behandelt.



Täglich zufriedene Eltern und Kinder zu sehen, welche bei sich selbst die positiven Veränderungen spüren, erfreut mich und mein Team – und motiviert uns jeden Tag neu!

Auch unsere Tochter atmet mittlerweile durch die Nase, schnarcht schon lange nicht mehr und hat keinerlei Apnoen.

Ihr Zungenband habe ich getrennt, und sie absolvierte unser **Richmosmile- Trainingsprogramm**, wodurch sich Kiefer und Atemwege toll entwickelt haben. Als Teenager benötigte sie nur noch mit minimalem Aufwand herausnehmbare
Aligner, um alles schön gerade zu machen.

Sie hat einen tollen Schulabschluss gemacht und **studiert nun ebenfalls Zahnmedizin**, da sie selbst von diesem Thema überzeugt und begeistert ist –
wie auch schon ein paar andere meiner ehemaligen kleinen Patienten. Sie alle
möchten später so vielen Kindern wie möglich mit denselben Problemen helfen.

Ich freue mich, gemeinsam mit meinem kompetenten Team jetzt Ihrem Kind helfen zu können!

2000	Gründung der **Praxis Richmodent** mit meinem Mann – moderne Zahnmedizin für Erwachsene und Kinder in Köln (mittlerweile ca. 65 Mitarbeiter:innen)
2005	Spezialisierung auf Wurzelbehandlungen
2006	Spezialisierung auf Kinderzahnheilkunde
2009	Gründung des **Richmokids-Konzeptes** – ein umfangreiches, strukturiertes Konzept für die Kinderbehandlung Erste **Myobrace-Klinik** für kieferorthopädische myofunktionelle Therapie in Europa gegründet
2014	Spezialisierung auf klassische Kieferorthopädie – Wien
2017	**Spezialisierung auf Zungenbandtrennungen** bei Dr. Zaghi (Los Angeles, USA), Kotlow, Baxter, Ghaheri u. v. m.
2018	Zahnärztliche Schlafmedizin für Erwachsene bei der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Schlafmedizin
2019	**Spezialisierung auf kinderzahnärztliche Schlafmedizin** – Boston, USA
2020	Gründung der **Deutschen Gesellschaft für Orofaziale Myofunktion – DGMYO**
2022	Orthotropics bei Dr. Bill Hang, USA
2023	Spark-Masterkurs

MEHR INFOS UNTER

www.carolaengelberts.de

Mitglied bei

- Tongue Tie Professionals
- Zertifizierte Zungenbandzentren Deutschland – für Köln
- Member ASAP
- Member Airway Circle
- Member Airway Health
- AAPMD u. v. m.

AIRWAY KIDS
ATEMWEGS ORIENTIERTE KINDERZAHNHEILKUNDE

TEIL 1

GRUNDLAGENWISSEN

Atmung · Zunge · Kieferwachstum

Auf den folgenden Seiten erklären wir Ihnen kurz und verständlich, warum diese drei Dinge untrennbar zusammengehören.

- **Warum die Atmung so wichtig ist**
- **Mundatmung – mehr als eine Angewohnheit**
- **Das Zungenband**
- **U oder V? Die Form des Oberkiefers**
- **Alles hängt zusammen – der Kreislauf**
- **Checkliste für Eltern**
- **Warum früh behandeln?**

Verständlich erklärt – für die Gesundheit Ihres Kindes.

GRUNDLAGENWISSEN

Warum die Atmung so wichtig ist

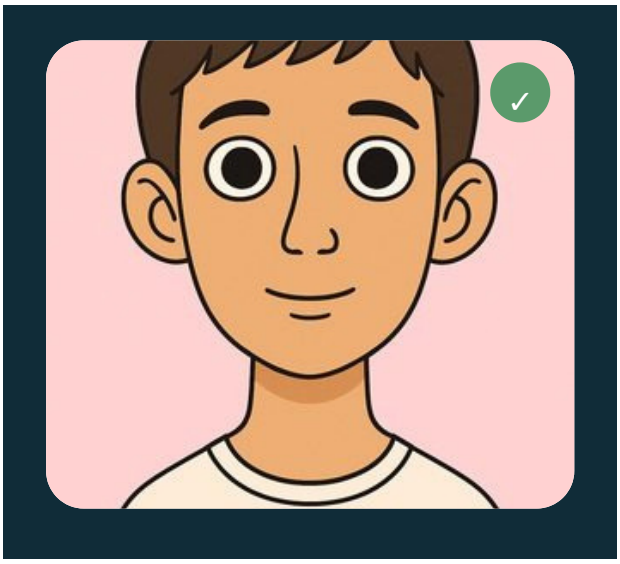
Die Nase – das Wunderwerk unseres Körpers

Die Nase ist viel mehr als ein Riechorgan: Sie ist **Filter, Heizung und Befeuchter** in einem. Nur bei der Atmung durch die Nase bekommt der Körper die Luft, die er für gesundes Wachstum und erholsamen Schlaf braucht.

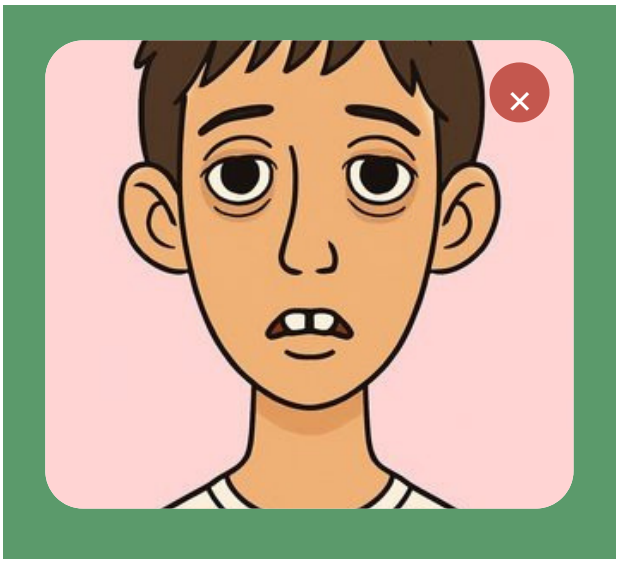
FILTER
reinigtdie Luftvon Staub und Keimen

HEIZUNG
erwärmt die Luft auf Körpertemperatur

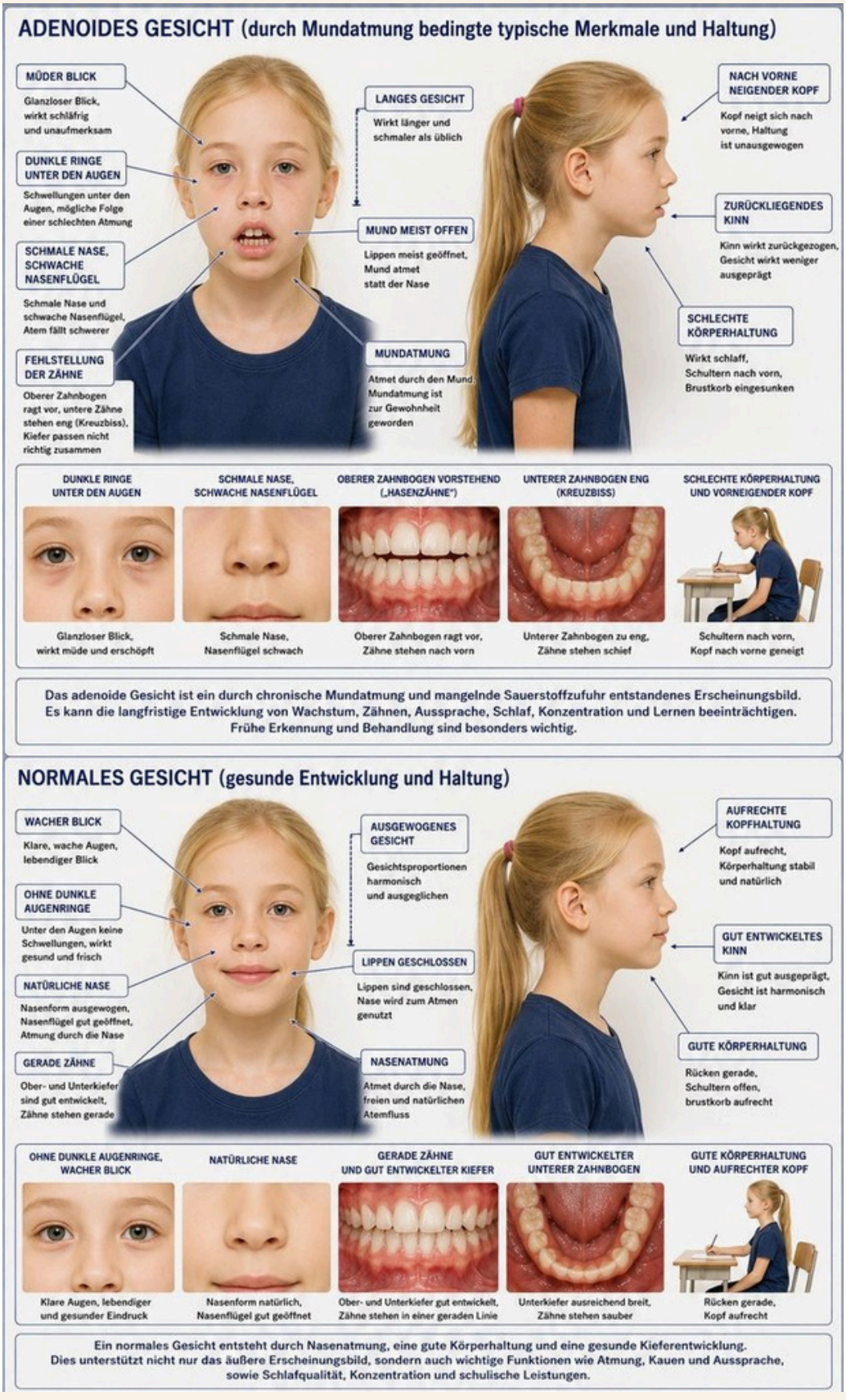
BEFEUCHTER
hält Schleimhäute und Atemwege gesund



NASENATMUNG
Lippengeschlossen, ZungeamGaumen – wach, fit und gesund



MUNDATMUNG
Mund offen,Zunge liegtunten– müde und oft krank


ADENOIDES GESICHT (durch Mundatmung bedingte typische Merkmale und Haltung)
MÜDER BLICK
Glanzloser Blick, wirkt schläfrig und unaufmerksam
DUNKLE RINGE UNTER DEN AUGEN
Schwellungen unter den Augen, mögliche Folge einer schlechten Atmung
SCHMALE NASE, SCHWACHE NASENFLÜGEL
Schmale Nase und schwache Nasenflügel, Atem fällt schwerer
FEHLSTELLUNG DER ZÄHNE
Oberer Zahnbogen ragt vor, untere Zähne stehen eng (Kreuzbiss), Kiefer passen nicht richtig zusammen
LANGES GESICHT
Wirkt länger und schmaler als üblich
MUND MEIST OFFEN
Lippen meist geöffnet, Mund atmet statt der Nase
MUNDATMUNG
Atmet durch den Mund, Mundatmung ist zur Gewohnheit geworden
NACH VORNE NEIGENDER KOPF
Kopf neigt sich nach vorne, Haltung ist unausgewogen
ZURÜCKLIEGENDES KINN
Kinn wirkt zurückgezogen, Gesicht wirkt weniger ausgeprägt
SCHLECHTE KÖRPERHALTUNG
Wirkt schlaff, Schultern nach vorn, Brustkorb eingesunken
DUNKLE RINGE UNTER DEN AUGEN
Glanzloser Blick, wirkt müde und erschöpft
SCHMALE NASE, SCHWACHE NASENFLÜGEL
Schmale Nase, Nasenflügel schwach
OBERER ZAHNBOGEN VORSTEHEND („HASENZÄHNE")
Oberer Zahnbogen ragt vor, Zähne stehen nach vorn
UNTERER ZAHNBOGEN ENG (KREUZBISS)
Unterer Zahnbogen zu eng, Zähne stehen schief
SCHLECHTE KÖRPERHALTUNG UND VORNEIGENDER KOPF
Schultern nach vorn, Kopf nach vorne geneigt
Das adenoide Gesicht ist ein durch chronische Mundatmung und mangelnde Sauerstoffzufuhr entstandenes Erscheinungsbild. Es kann die langfristige Entwicklung von Wachstum, Zähnen, Aussprache, Schlaf, Konzentration und Lernen beeinträchtigen. Frühe Erkennung und Behandlung sind besonders wichtig.
NORMALES GESICHT (gesunde Entwicklung und Haltung)
WACHER BLICK
Klare, wache Augen, lebendiger Blick
OHNE DUNKLE AUGENRINGE
Unter den Augen keine Schwellungen, wirkt gesund und frisch
NATÜRLICHE NASE
Nasenform ausgewogen, Nasenflügel gut geöffnet, Atmung durch die Nase
GERADE ZÄHNE
Ober- und Unterkiefer sind gut entwickelt, Zähne stehen gerade
AUSGEWOGENES GESICHT
Gesichtsproportionen harmonisch und ausgeglichen
LIPPEN GESCHLOSSEN
Lippen sind geschlossen, Nase wird zum Atmen genutzt
NASENATMUNG
Atmet durch die Nase, freien und natürlichen Atemfluss
AUFRECHTE KOPFHALTUNG
Kopf aufrecht, Körperhaltung stabil und natürlich
GUT ENTWICKELTES KINN
Kinn ist gut ausgeprägt, Gesicht ist harmonisch und klar
GUTE KÖRPERHALTUNG
Rücken gerade, Schultern offen, brustkorb aufrecht
OHNE DUNKLE AUGENRINGE, WACHER BLICK
Klare Augen, lebendiger und gesunder Eindruck
NATÜRLICHE NASE
Nasenform natürlich, Nasenflügel gut geöffnet
GERADE ZÄHNE UND GUT ENTWICKELTER KIEFER
Ober- und Unterkiefer gut entwickelt, Zähne stehen in einer geraden Linie
GUT ENTWICKELTER UNTERER ZAHNBOGEN
Unterkiefer ausreichend breit, Zähne stehen sauber
GUTE KÖRPERHALTUNG UND AUFRECHTER KOPF
Rücken gerade, Kopf aufrecht
Ein normales Gesicht entsteht durch Nasenatmung, eine gute Körperhaltung und eine gesunde Kieferentwicklung. Dies unterstützt nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch wichtige Funktionen wie Atmung, Kauen und Aussprache, sowie Schlafqualität, Konzentration und schulische Leistungen.

GRUNDLAGENWISSEN

Mundatmung

... ist mehr als nur eine Angewohnheit!

Atmet ein Kind dauerhaft durch den Mund, gerät die gesamte Entwicklung aus dem Gleichgewicht – **Tag und Nacht:**



Schnarchen und unruhiger Schlaf sind NICHT normal – sondern ein Warnsignal!

KIEFER & ZÄHNE
Der Oberkiefer bleibt schmal – kein Platz für die bleibenden Zähne.

SCHLAF
Schnarchen, Atemgeräusche, Aufwachen, Bettnässen, unruhige Nächte – bis hin zu Atemaussetzern.

KONZENTRATION
Müdigkeit, Zappeligkeit und Konzentrationsprobleme am Tag.

GESUNDHEIT
Häufigere Erkältungen, Infekte und vergrößerte Mandeln oder Polypen.

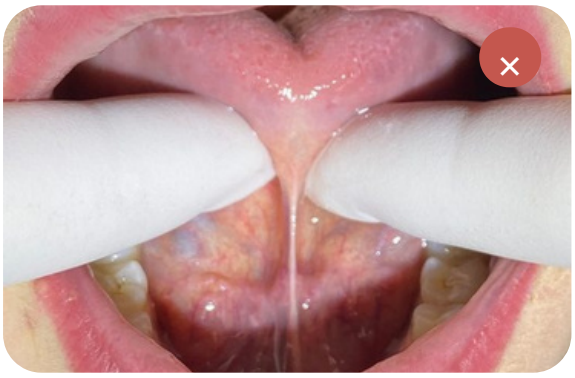
GESICHT
Das Gesicht wächst lang und schmal statt breit und harmonisch.

GRUNDLAGENWISSEN

Das Zungenband

Klein, aber mit großer Wirkung

Unter der Zunge sitzt das Zungenband. Ist es zu kurz, hält es die Zunge am Mundboden fest – sie kann ihre Funktion nicht voll ausführen, braucht Hilfsmuskeln, welche die Kieferform im Wachstum falsch beeinflussen, und die Zunge kann nicht in Ruhe komplett am Oberkiefer liegen, wo sie hingehört.



ZU KURZES ZUNGENBAND
Zungenfunktion und Ruhelage sind eingeschränkt



FREIE ZUNGE
Die Zungekannsichvollbewegen

DIE ZUNGE IST DER BAUMEISTER DES OBERKIEFERS

Liegt die Zunge Tag und Nacht sanft am Gaumen, formt sie den Oberkiefer von innen – breit genug für alle Zähne und für eine freie Nasenatmung. Fehlt dieser natürliche „Innendruck", drückt die Wangenmuskulatur den Kiefer schmal und hoch.

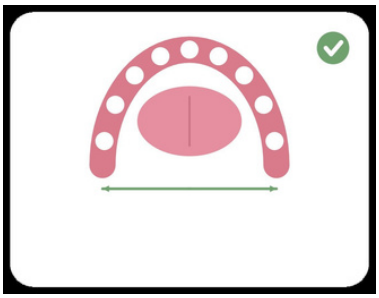
Ein zu kurzes Zungenband kann außerdem Stillen, Essen und Sprechen erschweren – deshalb schauen wir es uns **bei jeder Diagnostik ganz genau an!**

GRUNDLAGENWISSEN

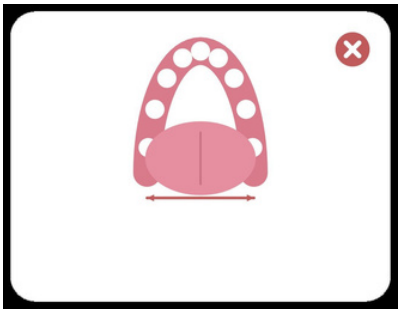
U- oder V-Form?

Warum die Form des Oberkiefers über die Atmung entscheidet

Ein gesunder Oberkiefer ist **breit und U-förmig** – geformt von der Zunge am Gaumen. Liegt die Zunge unten, bleibt der Kiefer schmal und hoch: **die V-Form.**



U-FORM: Zähne, Zunge und Nase haben Platz



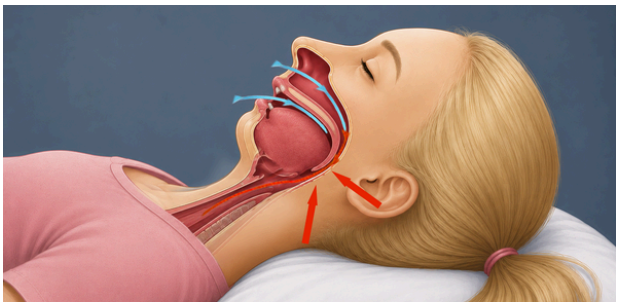
V-FORM: zu eng für Zähne, Zunge und Nase

GUT ZU WISSEN: Der Gaumen ist zugleich der Boden der Nase!
Ein schmaler, hoher Gaumen engt die Nasenatmung von unten ein – Mundatmung wird zur Regel. Die Nasenscheidewand wächst schief.

NACHTS WIRD ES ENG



Zunge am Gaumen: Der Atemweg bleibt frei.



Zunge liegt unten: Im Schlaf sinkt sie nach hinten und verengt den Atemweg.

SCHNARCHEN & LAUTE ATMUNG
Die Luft muss sich an der Engstelle vorbeizwängen – es rauscht und schnarcht.

UNRUHIGER SCHLAF
Der Körper schreckt immer wieder auf, um die Atmung zu sichern – bis hin zu Atempausen.

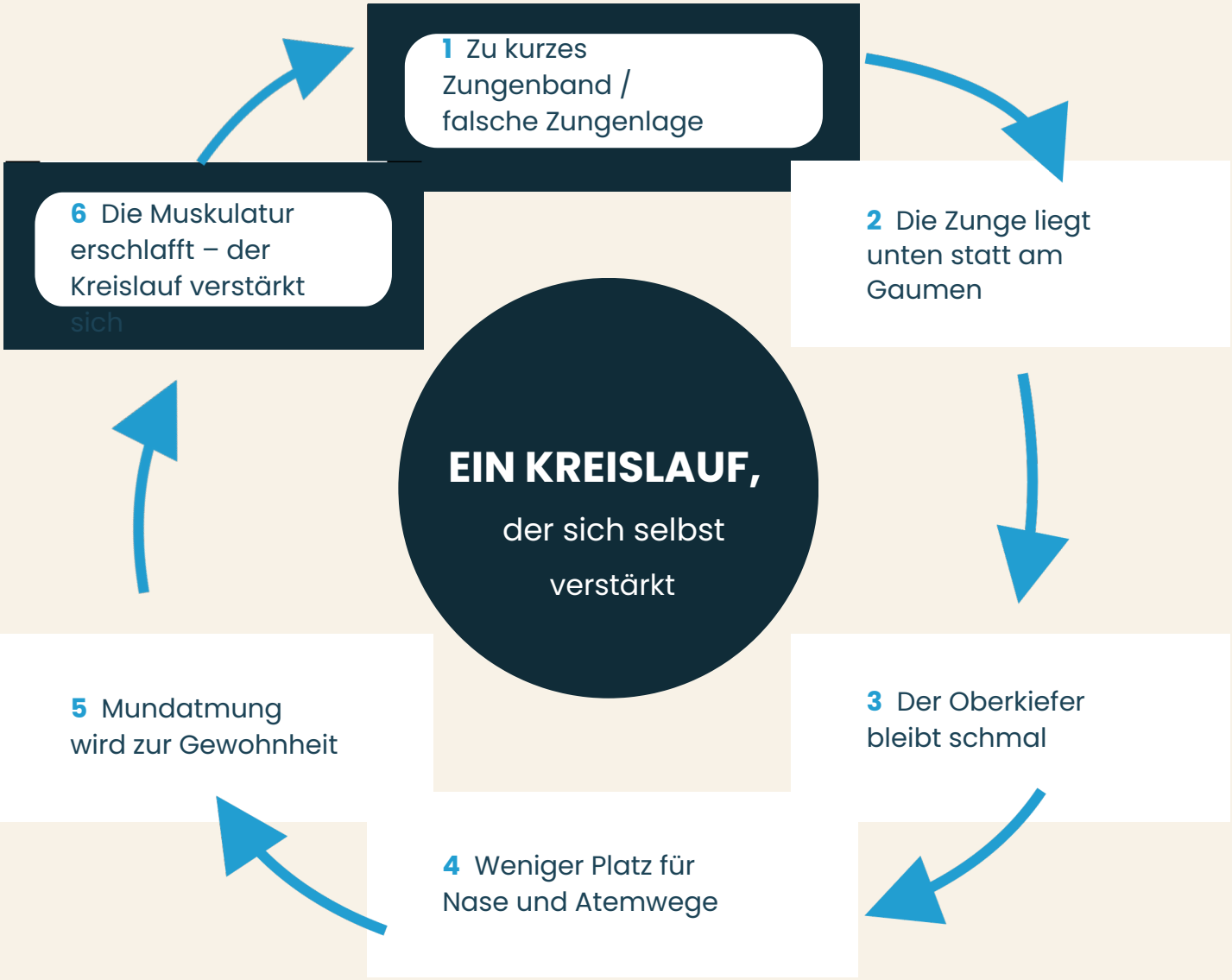
ZÄHNEKNIRSCHEN
Ein Schutzreflex: Der Unterkiefer schiebt sich vor, um den Atemweg wieder zu öffnen.

„ADHS-ÄHNLICHE" SYMPTOME
Ohne Tiefschlaf: tagsüber müde, zappelig, unkonzentriert – wird häufig verwechselt!

GRUNDLAGENWISSEN

Alles hängt zusammen

So entsteht der Kreislauf



DIE GUTE NACHRICHT:

Dieser Kreislauf lässt sich durchbrechen! Je früher Zungenlage, Atmung und Kieferwachstum in die richtige Bahn gelenkt werden, desto einfacher ist es – **genau hier setzt unser Airway-Kids-Konzept an.**

GRUNDLAGENWISSEN

Checkliste für Eltern

Woran Sie erste Anzeichen erkennen

Beobachten Sie Ihr Kind einmal bewusst – tagsüber und im Schlaf.
Ich empfehle eine Nachtsichtkamera!

- ☐ Schläft mit offenem Mund oder hat tagsüber oft die Lippen geöffnet
- ☐ Schnarcht, atmet laut oder hat nachts sogar kurze Atempausen
- ☐ Schläft unruhig, wälzt sich, nimmt ungewöhnliche Schlafpositionen ein
- ☐ Ist tagsüber müde, quengelig, zappelig oder unkonzentriert
- ☐ Knirscht nachts mit den Zähnen
- ☐ Ist häufig erkältet, hat oft eine verstopfte Nase oder Polypen
- ☐ Lispelt oder hatte einen späten Sprachbeginn
- ☐ Isst langsam, schmatzt oder mag keine festen Speisen
- ☐ Hat schiefe, eng stehende Zähne oder einen schmalen Kiefer
- ☐ Nässt nachts noch ein, obwohl es dem Alter entwachsen ist

MEHRERE HÄKCHEN GESETZT?

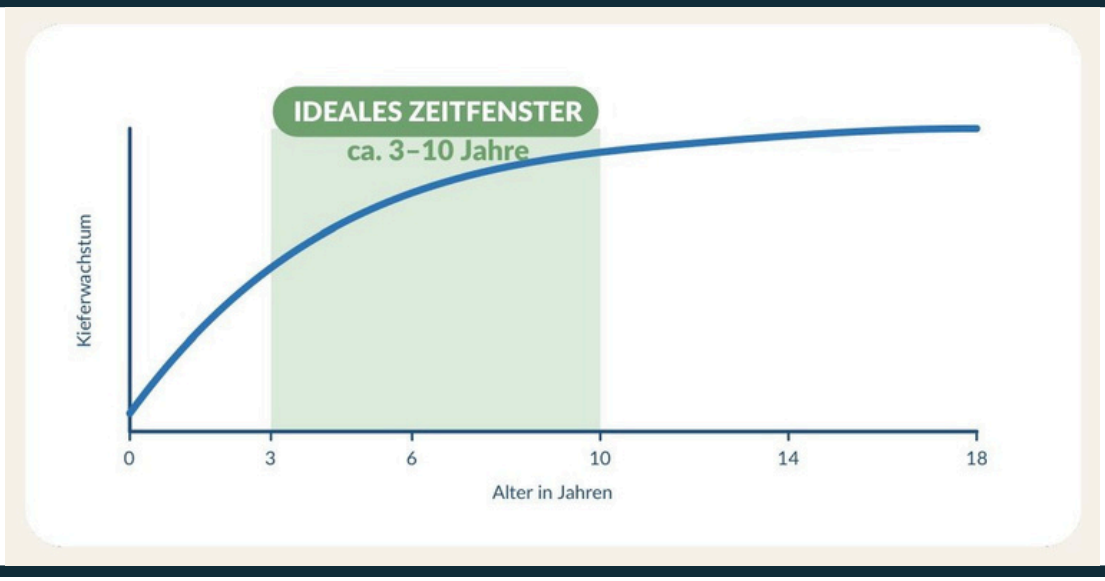
Dann lohnt sich ein genauer Blick! Sprechen Sie uns einfach an – wir untersuchen Atmung, Zungenband und Kieferentwicklung Ihres Kindes ganz in Ruhe.

GRUNDLAGENWISSEN

Warum früh behandeln?

Das Wachstum als Verbündeten nutzen

Der kindliche Kiefer wächst in den ersten Lebensjahren am stärksten. **70 % des Oberkieferwachstums sind mit 6 Jahren abgeschlossen.** Genau dieses Wachstum nutzen wir, um sanft zu lenken – statt später aufwendig zu korrigieren.



- ✓ **WACHSTUM LENKEN** – Kleine Impulse zur richtigen Zeit ersetzen große Korrekturen im Teenageralter.
- ✓ **PLATZ SCHAFFEN** – Für alle bleibenden Zähne UND für freie Atemwege – beides gehört zusammen.
- ✓ **BESSER SCHLAFEN** – Freie Nasenatmung bedeutet erholsamen Schlaf, mehr Energie und Konzentration.
- ✓ **KÜRZER & SANFTER** – Frühe Therapie ist meist einfacher, kürzer und angenehmer für Ihr Kind.

Früh hinschauen heißt: kleine Ursachen behandeln, bevor sie zu großen Problemen werden.

IHR WEG MIT UNS

Der Ablauf nach der Beratung

01 **Diagnostik**

02 **Individuelle Planung** für Ihr Kind

03 Erstellung des **Kostenvoranschlags**

04 **Start der Behandlung** nach Kostenzusage

05 Nach Abschluss: **Recall-Check** – 1× jährlich



TEIL 2

BEHANDLUNGSABLAUF

So begleiten wir Ihr Kind – Schritt für Schritt.

Die Behandlung dauert bei 3- bis 10-jährigen Patienten

6 bis maximal 12 Monate.

Ziel dieser frühen Therapie ist es, **jetzt die richtige Kieferentwicklung zu fördern** und somit **Platz für die bleibenden Zähne und die Atemwege** zu schaffen!

Gleichzeitig werden **Atmung und Schlaf positiv beeinflusst**, was wiederum für die gesamte Entwicklung des Kindes förderlich ist.

Recall-Check

Die Retentionsphase nach der Behandlung

Anschließend folgt eine Retentionsphase, in der Sie **1× pro Jahr** zum sogenannten **Recall-Check** zu uns in die Praxis kommen.

Meine Mitarbeiter erstellen die nötigen Unterlagen und senden mir diese abends zu.

Solange Sie nichts von uns hören, verläuft alles so wie geplant!

Je nach **Alter**, **dentaler Situation beim Start** und der **Mitarbeit** während der Therapie- und Retentionsphase muss ggf. im Teenageralter eine klassische kieferorthopädische Behandlung stattfinden, um die Zähne gerade auszurichten.

Das besprechen wir dann ganz in Ruhe beim Recall-Check – **Sie werden rechtzeitig informiert.**

Starten wir erst in der zweiten Wechselgebissphase, ab ca. 8/9 Jahren …

… ändert sich die Reihenfolge, und es schließt sich **sicher** eine spätere Alignerphase oder klassische KFO-Behandlung an, da sich der bereits so lange bestehende Platzmangel der bleibenden Zahnkeime nicht mehr komplett optimieren lässt.

Deshalb gilt: Je früher wir starten, umso besser für die Entwicklung!

BEHANDLUNGSABLAUF

Die Behandlungen

Wir versuchen, die Anzahl der Besuche in unserer Praxis **so gering wie möglich** zu halten, da wir viele Patienten aus ganz Deutschland und Europa haben.



Deshalb haben wir einen Workflow entwickelt, bei dem wir **Remote- Trainings und -Kontrollen** absolvieren …

… und auch der Verlauf der kieferorthopädischen Therapie kann **über Video und per KI** überwacht werden! Dabei hilft uns …



Gleichzeitig dient uns **Dental Monitoring** als Kommunikationstool mit den Kindern, Patienten und Eltern.

BEHANDLUNGSABLAUF

Individuell für jedes Kind!

Die Therapieplanung ergibt sich bei jedem Kind aus verschiedenen Komponenten.



Nach einer ausführlichen Diagnostik erhalten Sie einen **Kostenvoranschlag per Mail**, welcher am Anfang eine **Auflistung der individuellen Behandlungsschritte für Ihr Kind** enthält. Damit können Sie genau sehen, was geplant ist.

TEIL 3

DIE THERAPIE-OPTIONEN

01 **Festsitzende GNE**	02 **Herausnehmbare Geräte**	03 **Aligner**
04 **Richmosmile-Myofunktionsprogramm**	05 **Zungenband trennung**	06 **Positioner**
07 **Facemask**	08 **Retainer**	09 **Gummizüge**

Was Ihr Kind bekommt, entnehmen Sie bitte dem Kostenvoranschlag!

01

THERAPIE-OPTION

Festsitzende GNE



Die **Gaumennahterweiterungs-Apparatur** wird fest eingesetzt, um den Oberkiefer zu weiten.

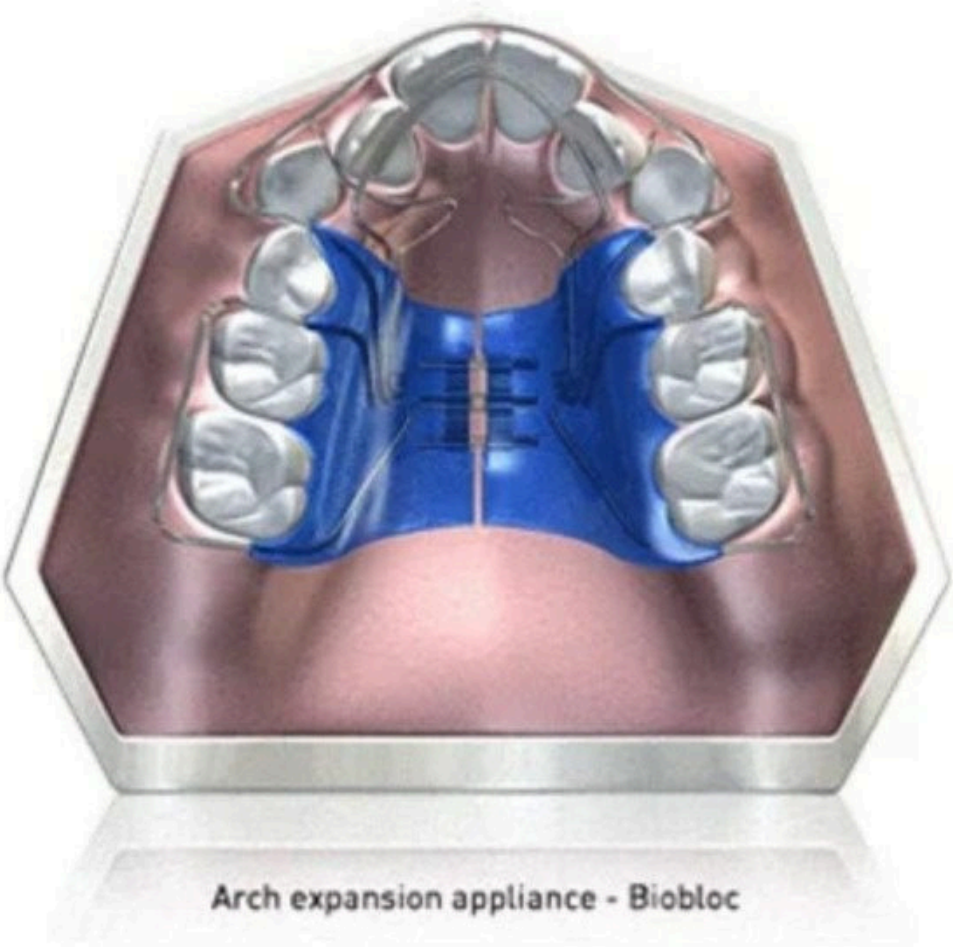
Nach einem Scan werden unsere Apparaturen mittels **CAD/CAM-Technologie** in einem Spezial-Dentallabor hergestellt – durch die präzise Fertigung sind weniger Sitzungen nötig!

Tragezeit: ca. 3–12 Monate

02

THERAPIE-OPTION

Herausnehmbare Geräte



Herausnehmbare **Gaumennahterweiterungs-Apparatur** – sie weitet den Oberkiefer sanft und kann zum Essen und Zähneputzen herausgenommen werden.

03

THERAPIE-OPTION

Aligner



Herausnehmbare Schienen, welche **24 Stunden täglich** getragen, nur zum Essen herausgenommen und **wöchentlich gewechselt** werden. Nach einer vorherigen digitalen Planung können wir so die Zähne dorthin bewegen, wo wir sie haben wollen.

Zur Befestigung werden meistens kleine **Kunststoff-Attachments** auf die Zähne geklebt, welche am Ende wieder entfernt werden!



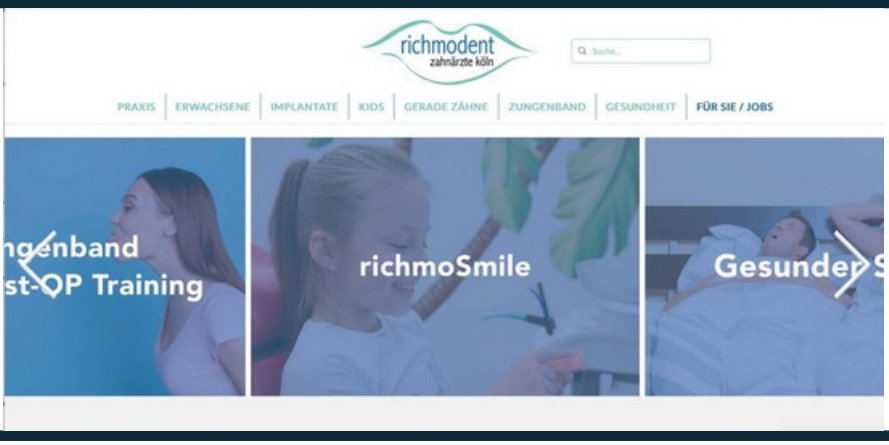
Die kieferorthopädische Behandlung mit **Alignern schon bei den Kleinsten ab ca. 3 Jahren** ist bereits bei der Planung völlig **anders als bei Erwachsenen**.

Ebenso sind die Trageanweisungen und auch die Herstellung nicht mit Erwachsenen-Alignern vergleichbar.

Bei uns dürfen zum Beispiel die Kleinsten **mit den Schienen essen** und müssen sie nur zum Zähneputzen herausnehmen.

THERAPIE-OPTION

04 Das Richmosmile-Myofunktionsprogramm



Nach der myofunktionellen Auswertung wird speziell für Ihr Kind ein **entsprechendes Programm mit passenden Übungen** in unserem internen Portal auf unserer **Homepage** freigeschaltet. Sie werden von uns in die Übungen eingewiesen, und wir erläutern Ihnen die Ziele.

Das Training besteht aus zwei Bausteinen: dem **Trainingsgerät**, welches Ihr Kind **2 Std. am Tag und die ganze Nacht – JEDEN TAG – tragen** muss, und **täglich 10 Minuten Übungen**!

Die Trainingsgeräte wechseln und sind alle in der aktiven Phase im Preis enthalten – es sei denn, sie gehen verloren oder kaputt! In bestimmten Intervallen findet entweder vor Ort oder per Video ein **Kontrolltraining** statt.

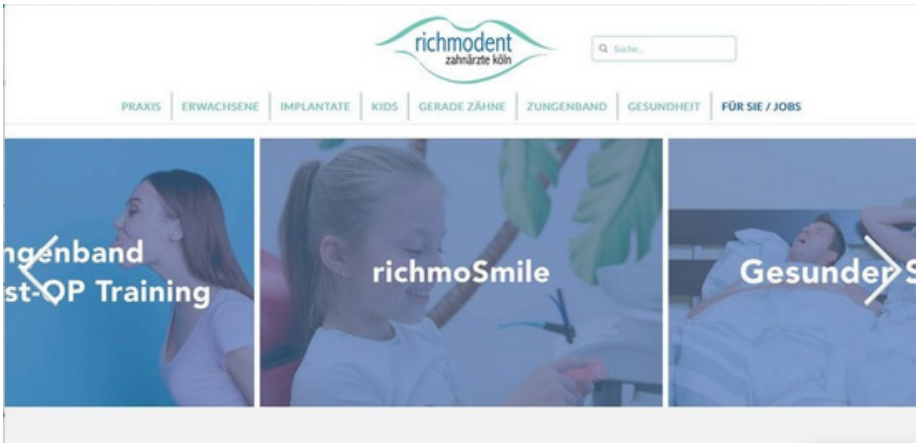
Zwei Programme – passend zum Alter Ihres Kindes:

FÜR DIE KLEINEN · 3–6 JAHRE
Gesunder Start
4 Monate

oder

FÜR DIE ÄLTEREN KINDER
Gesundes Wachstum
6 Monate

Beide Programme gibt es jeweils in zwei Stufen: **Anfänger** und **Fortgeschrittene**.



Die Übungsvideos finden Sie jederzeit im **passwortgeschützten Bereich unserer Homepage**.

05

THERAPIE-OPTION

Die Zungenbandtrennung



… ist bei uns

nicht einfach nur ein **„kleiner Schnipp mit der Schere“**,
eine sogenannte „Quick-Fix-Lösung“ …

… sondern eine Zungenbandtrennung mit einem Konzept!

Die moderne myofunktionelle linguale Faszienplastik mittels CO_2-Laser.

ZungenBandZentrum Köln

05

THERAPIE-OPTION

Die Zungenbandtrennung





Verkürztes Lippenband

Ich schaue mir

alle oralen Restriktionen an,

wie Zungen-, Lippen- und Wangenbänder.

Wir gehören zu den ersten zertifizierten Zungenbandzentren Europas.

ZungenBandZentrum Köln

Nicht jedes verkürzte Zungenband muss getrennt werden – nur diejenigen, welche die Funktion der Zungenmuskulatur beim Schlucken **(2.000–3.000-mal pro Tag!)** beeinflussen.

Denn das kann sonst Auswirkungen haben auf:

- **Sprache**
- **Schiefe Zähne durch Platzmangel**
- **Schlaf**
- **Konzentration**
- **Würgereiz**
- **Kieferentwicklung**
- **Mundatmung**
- **Bettnässen**
- **Essverhalten**

Ob eine Trennung sinnvoll ist, klären wir immer erst nach einer **gründlichen Funktions untersuchung** – nie „auf Verdacht“.

Vor- und Nachbereitung

Die Kinder und Erwachsene absolvieren ein **prä- und postoperatives Training**, um die verkümmerte Muskulatur zu aktivieren.

Hierfür stellen wir **spezielle Übungsvideos** im passwortgeschützten Bereich unserer Homepage zur Verfügung.



Übung mit dem Spiegel

Der Eingriff

BEI BABYS

im **Wachzustand** – schnell und sanft.

Ganz ohne Naht: Die Wunde wird nicht vernäht.

BEI KINDERN VON 2 BIS CA. 11 JAHREN

in einer **kurzen Vollnarkose** (ca. 20 Minuten) durch geschulte Kinderanästhesisten in unserer Praxis.

Die Wunde wird danach vernäht.

06

THERAPIE-OPTION

Der Positioner

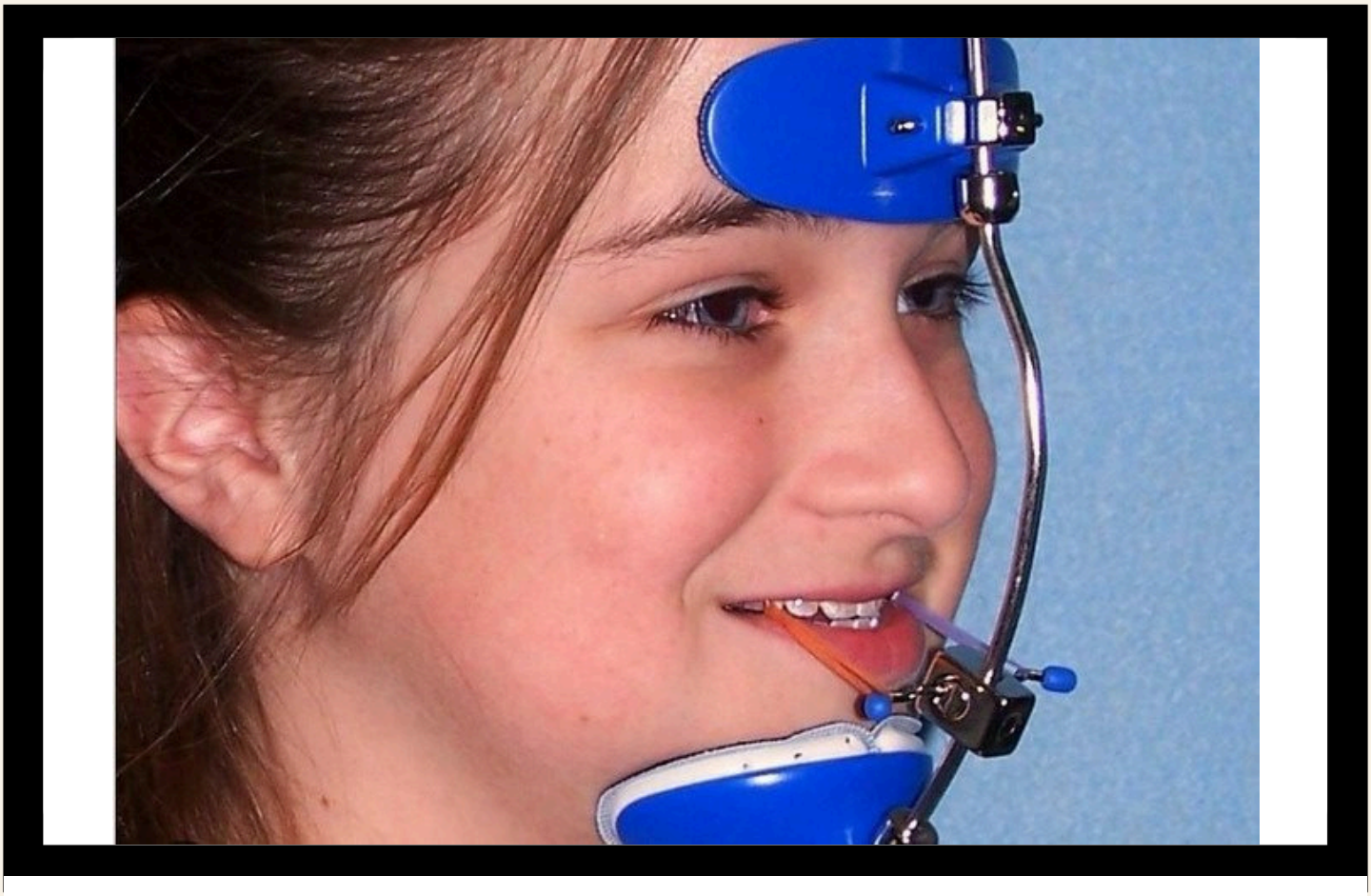


Nachdem im Labor die Zähne in idealer Position aufgestellt wurden, wird ein sogenannter **Positioner** hergestellt. Diesen müssen die Kinder **täglich nachmittags und nachts** – meistens über einen Zeitraum von **3–6 Monaten** – mit geschlossenem Mund tragen!

07

THERAPIE-OPTION

Die Facemask



Um einen unterentwickelten Oberkiefer nach vorne zu holen, benutzen wir in Kombination mit einer festsitzenden Gaumennahterweiterung (GNE) und Gummizügen eine sogenannte **Facemask**.

Diese wird über einen **relativ kurzen Zeitraum** nachmittags und nachts getragen.

08

THERAPIE-OPTION

Retainer







Stabile Ergebnisse für ein gesundes Lächeln!

Wir setzen in den verschiedenen Wachstumsphasen gezielt unterschiedliche Retainer ein, um das erreichte Behandlungsergebnis langfristig zu sichern. Damit Ihr Kind von den bestmöglichen Ergebnissen profitiert, ist es wichtig, dass der Retainer **jede Nacht** getragen wird. So bleibt die Zahnstellung stabil und das Wachstum kann sich optimal entwickeln.

Durch regelmäßige **Recall-Checks** alle 6–12 Monate behalten wir den Fortschritt genau im Blick und können individuell anpassen, wenn nötig. So stellen wir sicher, dass alles in die richtige Richtung wächst! Sollte der Retainer nicht regelmäßig getragen werden, kann sich die Zahnstellung wieder verschieben – und dann wäre eine weitere Kontrolle nicht zielführend.

Mit konsequentem Tragen sorgen wir gemeinsam für ein gesundes und schönes Lächeln – ein Leben lang!

09

THERAPIE-OPTION

Gummizüge



Um gewisse Bewegungen bei einer Alignerbehandlung oder in Kombination mit einer Facemask umsetzen zu können, benötigen wir die Hilfe von **Gummizügen**. Diese müssen unbedingt nach Anweisung **täglich** getragen werden – ansonsten finden diese Bewegungen **nicht** statt!

GEMEINSAM ZUM ERFOLG

Ohne Mitarbeit geht es nicht!

Ihr Einsatz zählt!



Jeden Tag sehen wir, wie positiv unsere Therapie von Kindern und Eltern angenommen wird – und wie groß die Erfolge sind! **Der entscheidende Faktor für eine nachhaltige Verbesserung ist jedoch Ihre Unterstützung als Eltern.**

Damit Ihr Kind die bestmöglichen Fortschritte macht, ist es wichtig, dass Sie zu Hause konsequent darauf achten, dass unsere Anweisungen umgesetzt werden. **Ihre aktive Begleitung macht den Unterschied!**

Falls das momentan nicht umsetzbar ist, empfehlen wir, mit der Therapie zu warten und gegebenenfalls den klassischen kieferorthopädischen Weg zu wählen.

Wir sind bereit, Ihr Kind auf diesem besonderen Weg zu begleiten – gemeinsam schaffen wir es!

GUT ZU WISSEN

Die Kosten

Bei **privat Versicherten** hängt die Erstattung der Behandlung von den individuellen Vertragsbedingungen ab.

Bei **gesetzlichen Krankenkassen** wird ein kleiner Teil übernommen, sobald eine Zahnfehlstellung im Sinne der **KIG-Einstufung** vorliegt. Grundsätzlich übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten nicht.

Falls Sie eine **private Zusatzversicherung** haben, richtet sich die Erstattungsmöglichkeit nach den spezifischen Tarifbedingungen.

Bei **Beihilfepatienten** richten sich die Versicherungen erfahrungsgemäß nach den gesetzlichen Krankenkassen!

Ob Ihr Kind sich in einer sogenannten KIG- Einstufung befindet, steht in Ihrem Kostenvoranschlag.



IHR NÄCHSTER SCHRITT

Wie geht es weiter?



Geben Sie Ihrem Kind die beste Chance für eine gesunde Zukunft!
Die richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt kann den Unterschied machen – für eine bessere Schlafqualität, eine gesunde Kieferentwicklung und das allgemeine Wohlbefinden Ihres Kindes. **Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um aktiv zu werden!**

Sie erhalten den digitalen Kostenvoranschlag. **Sobald Sie diesen unterschreiben, starten wir.** Falls Ihr Diagnostiktermin erst kürzlich war, können wir ohne Verzögerung beginnen – wir melden uns bei Ihnen!

Damit die Entscheidung für Sie noch einfacher wird: **Eine Ratenzahlung ist jederzeit möglich!** Bis zu 6 Raten sind **zinsfrei**, mit einem Mindestbetrag von **50 € pro Monat**.

Lassen Sie uns gemeinsam den besten Weg für Ihr Kind gehen – wir freuen uns, Sie zu begleiten!
Bitte melden Sie sich jederzeit bei

Rückfragen Richmosmile@richmodent.de
Propblemen direkt bei mir: c.engelberts@richmodent.de.

WICHTIG

Individuelle Behandlungsplanung

– aus Überzeugung und Verantwortung

Die Behandlungsplanung, die Sie von mir erhalten haben, ist **individuell auf Ihr Kind abgestimmt** – auf Basis moderner medizinischer Erkenntnisse und meiner persönlichen Erfahrung mit genau diesen Themen.

Dabei greifen alle empfohlenen Schritte ineinander. Nur so kann das volle Behandlungspotenzial ausgeschöpft werden.

Ich bitte um Verständnis, dass ich einzelne Maßnahmen nicht herauslöse oder nur Teile davon begleite.
Ich behandle ausschließlich im Rahmen des vollständigen Konzepts – aus Überzeugung und im Sinne der Gesundheit Ihres Kindes.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen,

Carola Engelberts

Bitte melden Sie sich jederzeit bei

- Rückfragen: Richmosmile@richmodent.de
- Problemen: direkt bei mir: c.engelberts@richmodent.de.